جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : مني محمد ابراهيم رزيق
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الازهر **العنوان :** ~~
رقم البطاقة : 25511280102082 **رقم التليفون :** 01204869327 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 28-11-1955 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منى محمد ابراهيم رزق
National ID: 25511280102082

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



IDMS
اشعة هادية عبدالصبر
مامو مبرام
سونار بطن وحوض

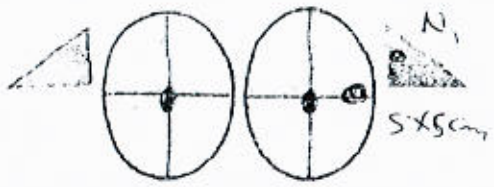


مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

المبادرة المصرية لصحة المرأة مصر

MDT FORM

Name	[illegible]
Age	70
MRN	[illegible]
ID	[illegible]
Co morbidity	- Cardiac arrhythmia on Isoptin one tab Daily - Asthmatic



Clinical Data

Bx: IDC.	SM: lt micrcalcfactiv
IHC: ER: 818 PR: 518 HerY: 0 KiY: 30%	Mets Workup: CTCAP → Free
T N M C2 1/18 0 5x4x3	
COMMENT: Lt MRM → $\overline{pT_2N_{1a}M_0}$ multicenteri IDC G II 2.5x.6 +LVI - ER → 84%	

MDT OUTCOME & PLAN

Rs- Adjuvat. TC X 4 cycles
(Txt + endoxan)
+ PORT
+ AI / 5y + zoka / 6mo

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
[illegible]		[illegible] 11/4/2022	

Name: منى محمد ابراهيم رزيق **MR. :** 4561	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

Post-mastectomy left breast cancer, T3 N1/18, status post left modified radical mastectomy on 20/12/2021. The patient has been on Femara (letrozole) since 4/2024 with a port placed in the femoral region. A new right axillary lymph node was identified on ultrasound; a repeat right axillary ultrasound is planned for Femara monitoring and for consideration of Zometa next month.

The patient is currently receiving Femara for a total of 3 months.

The patient is scheduled for an annual assessment. The visit was conducted for KARAR DUT to MOH purposes. The next visit is planned after 1 month, with pharmacy review and additional follow-up in the subsequent month.

A CT scan performed in June 2026 revealed a few scattered pulmonary nodules measuring 4 mm, likely post-radiation sequelae with sub-pleural reticulations; otherwise the study was free of disease. The next visit is scheduled for 9/10/2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : nada mohamed elsayed

يعتمد ,

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	:الأستاذه / منى محمد ابراهيم رزيق	Request No.	: 133745
Patient No.	:25511280102082	Request Date	: 20/12/2021
Path No.	:3165/21	Verification Date	: 30/12/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	:66 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer, did not receive chemotherapy.

Nature of the specimen:
Left modified radical mastectomy.

Gross Examination:
- Procedure: Left MRM specimen; measured 20x15x3 cm, covering skin ellipse measured 17x2 cm, nipple and areola were unremarkable.
- Localization: UOQ, LIQ
- Tumor extent
  - Number: UOQ ;Ill defined grayish white ruberry to firm mass
    LIQ; Ill defined grayish white ruberry to firm mass
  - Size: UOQ; 5x4x3 cm, LIQ; 2.5x1x0.6 cm.
  - Skin involvement: Away 1.5 cm from skin.
- Distance from margins: Away 1.5 cm from deep margin
- Lymph nodes number and size: 18 nodules up to 1.5 cm
- Additional pathologic findings: The two masses were 8 cm away from each other.
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section:N/A

Microscopic examination:
- Histological type: Multicenteric invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II
- Angioinvasion: Positive
- Ductal carcinoma in situ: Positive (15%)
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in 1/18
- Resection Margins: Free

Verified by :
walaa ghoniem

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

tient Name	:الأستاذه / منى محمد ابراهيم رزيق	Request No.	: 133745
tient No.	:25511280102082	Request Date	: 20/12/2021
h No.	:3165/21	Verification Date	: 30/12/2021
x	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
e	:66 Y	Department	: Out Patient
ferreing Doc	:	Registered by	: ,marwa mohamed youss

Pathology Report

Histologic response to therapy: N/A
Additional pathologic findings: Free nipple and areola.

iagnosis:
eft breast cancer; Left modified radical mastectomy:
Multicenteric invasive duct carcinoma, grade II
Ductal carcinoma insitu (15%)
Free nipple and areola
Free deep margin
Positive metastatic deposits in 1/18 axillary lymph nodes.
pT3 pN1a pMx.

Prof. Aml Hareedy
Dr.Walaa Ghonaim.

Verified by:
walaa ghonaim

National Women's Health Initiative Pathology Lab
معمل باثولوجيا المبادرة القومية لصحة المرأة

Patient Name	: الأستاذه / منى محمد ابراهيم رزيق	Request No.	: 139680
Patient No.	: 25511280102082	Request Date	: 11/10/2021
Path No.	: 2387/21	Verification Date	: 24/10/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 65 Y	Department	: Out Patient
Referreing Docto:		IHC No.	:

IMMUNOHISTOCH MISTRY REPORT

Clinical Data:
Lt breast mass, (BIRADs5)
Nature of the specimen:
Tru cut
Gross Examination:
five gray white tissue cores up to 1.3cm, totally submitted
Sections prepared from paraffin blocks for immune-staining using Bench-Mark ULTRA system for ER, PR, Her-2 and Ki67
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her-2 clone (4B5), & Anti-K-67 (30-9)

Microscopic examination:
- Histological type: IDC
- Grade II
- Angioinvasion: no
- Ductal carcinoma in situ: focal (solid type)

Diagnosis:
Lt breast mass, tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma GII
- Biomarkers:
  - o ER: strong Intensity 90% nuclear reaction (Allred score 8)
  - o PR: moderate Intensity 40% nuclear reaction (Allred score 5/8)
  - o Her2: negative membrane reaction (score 0)
  - o Ki67: 30% nuclear reaction

Prof. Gamal Abdelaty

Dr. Rana Fathy

Room No. (4) First Floor Building No. 9 Qadeem Cairo

Name Mona Mohammed Ibrahim

Date : 4-11-2021

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

** Given history of left breast cancer.

1. ***Chest:***

- Left breast UOQ enhancing parenchymal mass lesion is seen measuring about 2 x 1.4 cm .Associated prominent left axillary LN is seen measuring 1.5 x 1 cm.
- Few bilateral scattered pulmonary parenchymal tiny nodules are seen, largest at the superior segment of the right lower lobe, measures 5.5 mm.
- Bilateral basal , subpleural parenchymal bands, likely post-inflammatory sequel.
- Otherwise, No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is of mildly enlarged with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
- Spondylo-degenerative changes with mild central wedging of L1 vertebra.
- No destructive lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- Left breast UOQ enhancing parenchymal mass lesion along with prominent left axillary lymph node.
- Few bilateral scattered pulmonary parenchymal nodules , of benign nature, for close follow up.
- No hepatic metastatic deposits.

d.Ibraheem elsedawy,msc

Dr. M. Gomaa, M.D.